

Первая медицинская помощь при электротравме на рабочем месте программиста

Алгоритм действий

Шаг 1. Оценка обстановки и обеспечение собственной безопасности

- Немедленно прекратите воздействие тока на пострадавшего. Не бросайтесь сразу к человеку — вы сами можете попасть под напряжение.
- Самый безопасный вариант — отключить электропитание: вырубить автомат в щитке, выдернуть вилку из розетки, отключить сетевой фильтр. На рабочем месте программиста источниками опасности обычно выступают системный блок, монитор, удлинители, сетевые кабели, неисправные розетки.
- Если отключить питание быстро нельзя, освободите пострадавшего, используя предмет, не проводящий ток: сухую деревянную линейку, ручку от швабры, плотную сухую ткань. Можно оттянуть человека за сухую одежду (лучше одной рукой, вторую держать за спиной).
- Категорически нельзя: хватать пострадавшего за открытые участки тела или мокрую одежду, использовать металлические или влажные предметы, приближаться бегом или широкими шагами к лежащему на земле оголённому проводу (возникает шаговое напряжение — двигайтесь мелкими «гусиными» шажками либо прыжками на одной ноге).

Шаг 2. Вызов скорой помощи

- Сразу звоните 103 или 112. Чётко сообщите диспетчеру: что произошло (удар током), сколько пострадавших, их состояние (в сознании/без сознания, дышит/не дышит), точный адрес и ориентиры, как лучше подъехать.
- Не завершайте разговор, пока диспетчер не скажет «вызов принят».

Шаг 3. Оценка состояния пострадавшего

- Уложите человека на ровную твёрдую поверхность.
- Проверьте сознание: громко окликните, слегка потрясите за плечи.

- Проверьте дыхание: запрокиньте голову, поднимите подбородок; прислушайтесь к дыханию, почувствуйте выдыхаемый воздух щекой, посмотрите на движение грудной клетки (время оценки — не более 10 секунд).
- Проверьте пульс на сонной артерии (на боковой поверхности шеи): приложите 2–3 пальца и слегка надавите в сторону позвоночника (время оценки — не более 10 секунд).
- Осмотрите тело на наличие ожогов: ищите точки входа и выхода тока (часто это кисти, стопы, места контакта с металлическими частями мебели/корпусом ПК). Кожа может выглядеть как небольшое пятно, но повреждение тканей под ним бывает глубоким.

Шаг 4. Действия в зависимости от состояния пострадавшего

- Если человек в сознании, дышит, есть пульс. Уложите его удобно, расстегните давящую одежду, обеспечьте приток свежего воздуха. Не разрешайте вставать или возвращаться к работе — даже при лёгких симптомах нужна врачебная оценка. Приложите холод к местам ожогов (лёд в ткани, охлаждающий пакет), наложите сухую чистую повязку. Контролируйте состояние до приезда медиков.
- Если человек без сознания, но дышит, пульс есть. Придайте устойчивое боковое положение (чтобы при рвоте не было удушья), расстегните воротник, ослабьте галстук/ремень, обеспечьте доступ воздуха. Контролируйте дыхание и пульс каждые 2–3 минуты.
- Если нет сознания, нет нормального дыхания (редкое, судорожное) и нет пульса. Немедленно начинайте сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР):
 1. Положите пострадавшего на спину на твёрдую поверхность, освободите грудную клетку от одежды.
 2. Выполните 30 надавливаний на нижнюю треть грудины (глубина 5–6 см, частота 100–120 в минуту, руки выпрямлены в локтях, упор на ладони).
 3. Затем сделайте 2 вдоха методом «рот в рот» через барьер (марлю, специальную маску-клапан из аптечки). Если не готовы делать вдохи, продолжайте только компрессии.

4. Повторяйте цикл 30:2 до появления признаков жизни или до прибытия бригады скорой.

Шаг 5. Обработка видимых повреждений

- На места ожогов наложите сухую стерильную повязку из аптечки. Не используйте мази, масла, йод, зелёнку на свежих ожогах — это ухудшит состояние тканей. Не вскрывайте пузыри.
- При подозрении на переломы (если был резкий мышечный спазм или падение) ограничьте движения повреждённой конечности, зафиксируйте подручными средствами.

Шаг 6. Ожидание медиков и наблюдение

- Оставайтесь с пострадавшим до приезда скорой. Даже если он пришёл в себя и говорит, что всё в порядке, не отпускайте его одного.
- Будьте готовы снова начать СЛР, если состояние ухудшится.
- По возможности соберите информацию для врачей: как долго действовал ток, откуда шёл (розетка, сетевой фильтр, корпус ПК), было ли падение, терял ли человек сознание.